

1 Kontinenzanamnese

(nach dem ES Kontinenzförderung 2024)

Unmittelbar zu Beginn des pflegerischen Auftrags wird eine erste Einschätzung bei allen Personen mit einem pflegerischen Unterstützungsbedarf durchgeführt. Es wird routinemäßig, z. B. im Rahmen der pflegerischen Anamnese, nach ungewolltem Harn- und Stuhlverlust gefragt und vorhandene Risikofaktoren für eine Harn- und Stuhlinkontinenz werden identifiziert.

Eine respektvolle, empathische Grundhaltung der Pflegefachkräfte und ein geschützter Rahmen sind für die Durchführung der Einschätzung erforderlich. Je nach Versorgungssetting kann es zuerst entscheidend sein, eine ausreichende Vertrauensbasis zwischen Pflegenden und den zu versorgenden Menschen herzustellen.

1.1 Ersteinschätzung

Es werden **Risiken** und **Anzeichen** einer Inkontinenz überprüft. Sollten Risiken und Anzeichen für eine Inkontinenz identifiziert werden, erfolgt eine vertiefte Einschätzung der Kontinenzsituation.

Ergeben sich aus dem ersten Schritt keine Risiken und Anzeichen für eine Kontinenzproblematik, ist dies zu dokumentieren und eine vertiefte Einschätzung entfällt!

(z. B. mit einem einfachen Hinweis auf das Kontinenzprofil „Kontinenz“ in der Pflegeanamnese)

1.1.1 Risikofaktoren für eine Harn- und/oder Stuhlinkontinenz

s. Arbeitsblatt „Risikofaktoren für Harn- und Stuhlinkontinenz“

Risikofaktoren bei bestehender Kontinenz Risikofaktoren werden in die Anamnese aufgenommen, angewandte Kompensationsstrategien werden erfragt und dokumentiert, z. B. ob Schwangere oder Wöchnerinnen bei der Geburtsvorbereitung Übungen zum Beckenbodentraining kennengelernt haben oder ob bei einer Obstipation Maßnahmen zur Stuhlregulation bekannt sind und angewendet werden

1.1.2 Anzeichen/Symptome einer Inkontinenz

- Unwillkürlicher Harn- und/oder Stuhlverlust bei körperlicher Betätigung
- Unwillkürlicher Harn- und/oder Stuhlverlust einhergehend mit Drang
- Gefühl der nicht vollständig entleerten Blase bzw. Rektums
- Erfolglose Blasen- bzw. Darmentleerungsversuche
- Häufiger plötzlicher und unbeherrschbarer Drang ohne Harn- bzw. Stuhlverlust
- Verzögerter Beginn der Miktion bzw. Defäkation
- Ständiger Harnabgang bzw. Stuhlschmierer bemerkt oder unbemerkt
- Brennen beim Wasserlassen, das Gefühl wund zu sein

- Obstipation oder Diarrhöe
- Meteorismus
- Schmerzen

(s. 2. Aktualisierung des ES Seite 77 und 81, bzw. Arbeitsblatt „Anzeichen/Symptome einer Inkontinenz“)

1.2 Vertiefte Einschätzung

Eine vertiefte Einschätzung dient der systematischen Erfassung der Kontinenzsituation. Die Schritte der vertieften Einschätzung werden von der Pflegefachkraft eingeleitet und durchgeführt, bzw. im Rahmen interprofessioneller Zusammenarbeit bei anderen Berufsgruppen angeregt und im Rahmen der Steuerung des Pflegeprozesses zusammenführt.

Für die Einschätzung der Kontinenzsituation liegen für die Harnkontinenz und die Stuhlinkontinenz unterschiedliche Einschätzungsinstrumente vor. Von Seiten der Expert*innenarbeitsgruppe kann jedoch keine Empfehlung für die Nutzung eines bestimmten Einschätzungsinstruments ausgesprochen werden. Vielmehr gilt es, setting- und einrichtungsspezifisch zu prüfen, ob und wenn ja, welches Instrument die Einschätzung der Kontinenzsituation unterstützen kann.

1.2.1 Warn- bzw. Alarmsignale in Hinblick auf die Gesundheitssituation

Die Anzeichen einer Inkontinenz können auch gleichzeitig Symptome anderer Erkrankungen sein. Bei einer Einschätzung der Kontinenzsituation ist es deshalb wichtig, zu differenzieren, ob es sich ggf. um sogenannte Alarmsignale für schwerwiegende gesundheitliche Probleme handeln könnte.

Diese lassen sich unterteilen in Auffälligkeiten, die einer **engmaschigen Beobachtung (Yellow Flags)** bedürfen und Auffälligkeiten, die ein **sofortiges Handeln** erfordern (**Red Flags**). In beiden Fällen muss sofort eine Information an die behandelnden Ärzte bzw. Ärztinnen erfolgen!

	Harnausscheidung	Stuhlausscheidung
Yellow Flags	• Harninkontinenz durch Delirium, Infektionen, Medikamente • Stuhlinkontinenz	• Stuhlinkontinenz durch Delirium, Infektionen, Medikamente • Vermehrte Durchfälle
Red Flags	• Hämaturie • Dysurie • Paresen/Parästhesien • Überlaufsymptomaten • Druckgefühl in der Vagina	• Schmerzen beim Stuhlgang • Blutungen beim Stuhlgang • Blutauflagerungen

Symptome der Harninkontinenz	
Allgemeine Speichersymptome	• Erhöhte Harnfrequenz • Nykturie • Polyurie • Unfreiwilliger Harnverlust bei körperlichen Belastungen
Sensorische Symptome	• Erhöhtes Gefühl der Blasenfüllung • Plötzlich auftretender Harndrang • Reduziertes Gefühl der Blasenfüllung • Fehlendes Blasengefühl
Miktionsbeschwerden	• Verzögerung beim Einleiten der Entleerung • Paruresis (Unfähigkeit, Entleerung in der Öffentlichkeit einzuleiten) • Zwingender Harndrang • Episodische Unfähigkeit Miktion einzuleiten • Anstrengung bei der Entleerung • Schwacher Harnstrahl • Harntröpfchen am Ende der Entleerung • Positionsabhängige Miktion • Dysurie (schmerzhafte Blasenentleerung) • Strangurie (schmerzhafter nicht unterdrückbarer Drang) • Hämaturie • Pneumaturie (Gasausscheidung mit dem Urin) • Fäkalurie • Chylurie (Ausscheidung von Lympheflüssigkeit über die Harnwege, z.B. durch Fistelgänge) • Harnverhalt (akut oder chronisch) • Schmerzen bei der Miktion (Blase, Harnröhre, Skrotum, Damm) • Chronische Beckenschmerzen
Symptome nach der Blasenentleerung	• Gefühl der unvollständigen (Blasen-)Entleerung • Blasenentteerung • Notwendigkeit der sofortigen erneuten Entleerung • Weitere Dringlichkeit nach der Miktion

1.2.2 Initialfragen und weitere Nachfragen zur Kontinenzsituation

Folgende Initialfragen werden von der Expert*innenarbeitsgruppe empfohlen und sollten je nach Gegenüber, Anlass und Situation individuell formuliert werden. Diese Fragen bieten eine Orientierung für einen Gesprächseinstieg. Je nach Situation kann es beispielsweise sinnvoll sein, in einem ersten Schritt ein eher offen formuliertes Angebot zu machen, über die individuelle Kontinenzsituation zu sprechen.

Einstiegsfragen zur Harninkontinenz	Einstiegsfragen zur Stuhlinkontinenz
• Verlieren Sie ungewollt Urin? • Tragen Sie Vorlagen oder andere Hilfsmittel, um Urin aufzufangen? • Haben Sie Probleme Ihre Harnblase zu kontrollieren oder zu leeren?	• Verlieren Sie ungewollt Stuhlgang? • Haben Sie Probleme Darmwinde zurückzuhalten oder • andere Probleme mit ihrem Darm? • Gibt es Probleme mit verschmutzter Wäsche?

Nachfragen zur Harninkontinenz

- Sie beschreiben Probleme mit der Harnkontinenz, wie lange besteht dieses Problem schon?
- Kommt der Harndrang manchmal sehr plötzlich?
- Verlieren Sie manchmal Urin schon auf dem Weg zur Toilette?
- Verlieren Sie Urin, wenn Sie husten, niesen, lachen oder sich körperlich betätigen?
- Müssen Sie pressen, um Wasser zu lassen?
- Fühlt sich die Blase manchmal nicht richtig entleert an?
- Wie lange gibt es die Problematik bereits?
- Leiden Sie unter wiederkehrenden Blasenentzündungen?
- Haben Sie bereits etwas unternommen, um Ihre Situation zu verbessern?
- Gab es Manipulationen/medizinische Eingriffe an Ihrer Harnblase wie Katheteranlagen, Operationen oder Bestrahlungen im Beckenbereich?

Nachfragen zur Stuhlinkontinenz

- Sie beschreiben Probleme mit der Stuhlinkontinenz, wie lange besteht dieses Problem schon?
- Ist der Stuhlgang häufiger zu dünn oder zu fest?
- Wenn sie Stuhldrang verspüren, können sie dann den Stuhl halten und schaffen den Weg bis zur Toilette?
- Haben Sie das Gefühl, dass sich der Darm nicht vollständig entleert?
- Wie lange gibt es die Problematik bereits?
- Haben Sie bereits etwas dagegen unternommen?
- Verwenden Sie Vorlagen oder andere Hilfsmittel, um Stuhl aufzufangen?
- Verwenden Sie Hilfsmittel, um den Darm kontrolliert entleeren zu können?
- Sind bei Ihnen Lebensmittelunverträglichkeiten/-allergien bekannt?
- Gab es Manipulationen/medizinische Eingriffe an Ihrem Darm wie Operationen oder Bestrahlungen im Beckenbereich?

Bei unbeantworteten Fragen sollte die Pflegefachkraft diskret auf Hinweise, Auffälligkeiten und pflegerelevante Befunde achten z. B.

- häufige Toilettengänge
- Wäsche verstecken
- Bett öfters abziehen
- unruhiges Verhalten
- auffälliger Geruch
- Hautveränderungen im Intimbereich
- Stürze u.a.

Wenn Inkontinenzprobleme in der Verbindung mit sexualisierter Gewalt oder einer Vergewaltigung vermutet werden, bedeutet dies für die Betroffenen eine doppelte Tabuisierung.

Hinweise darauf könnten sein

- Abwehrverhalten bei intimen Verrichtungen
- nicht ohne Weiteres erklärbare vaginale oder rektale Blutungen
- Verletzungen im Intimbereich

Bei bestehendem Verdacht auf eine derartige Situation, sollte das Gespräch sehr behutsam darauf gebracht werden, da eine Retraumatisierung ausgelöst werden könnte.

1.2.2 Weitere Aspekte der vertieften Einschätzung

- alle **Risikofaktoren** werden analysiert
- **Trink- und Ernährungsgewohnheiten** werden ermittelt
 - (Bevorzugte Getränke oder Nahrungsmittel wie beispielsweise Kaffee, bestimmte Teesorten, Spargel, Kohl, Ballaststoffe aber auch Alkohol können harn- oder stuhltreibend sein)
 - durchschnittliche **tägliche Trinkmenge** wird erfragt bzw. in einem Miktionsprotokoll erfasst
- **Lebensmittelallergien** werden erfragt
- **Medikamente** werden geprüft, ob diese einen Einfluss auf die Ausscheidungsfunktionen haben (b. B. Information an den Arzt, um die medikamentöse Therapie entsprechend anpassen zu können, in einigen Fällen, kann es sinnvoll sein, die Einnahme- oder Tageszeit der individuellen Kontinenzsituation anzupassen z. B. bei Diuretika oder Laxantien)
- **funktionelle Beeinträchtigungen** werden überprüft,
 - z. B. welche Tätigkeiten/Bewegungen von der Person selbständig oder mit Unterstützung erfolgen können,
 - welche Förderpotentiale vorhanden sind und ob diese durch gezielte Maßnahmen verbessert werden können.
- **Inspektion des Urogenital- und Analbereichs** erfolgt
 - Informationen bezüglich der Hautbeschaffenheit (Atrophie der Schleimhaut, Hämorrhoiden, Gewebsveränderungen, Verletzungen und Entzündungen)
 - auf Anzeichen einer inkontinenzassoziierten Dermatitis (IAD) wird geachtet
- bereits **durchgeführte Operationen an der Blase bzw. dem Darm**,

- diese können Auswirkungen auf die Auswahl von spezifischen Maßnahmen bzw. dem Einsatz von Hilfsmitteln haben kann
- Bei Männern mittleren Alters (ab 55 Jahren) werden **Vorerkrankungen der Prostata** erfragt
- Bei einer **Berufs- und Sozialanamnese** sind **körperliche Belastungen** wie Heben und Tragen von schweren Gewichten zu erfragen, die in Verbindung mit beruflichen oder Freizeitaktivitäten stehen, da es hierbei zu einer Überbelastung und daraus resultierenden Schwächung der Beckenbodenmuskulatur kommen kann
- die **Hilfsmittelversorgung** wird erfasst

1.2.2.1 Spezifische Aspekte für eine vertiefte Einschätzung der Harninkontinenz

Hinweise auf Harnwegsinfekte

- bei plötzlich auftretender Harninkontinenz und/oder schmerzhafter Miktio
- je settingspezifisch
 - eine Schnelltestanalyse des Harns auf Blut, Leukozyten und Nitrit
 - B. B. sind mit dem behandelnden Arzt weitere diagnostische Maßnahmen abzustimmen.
 - Bei Vorliegen einer Infektion ist ärztlicherseits eine entsprechende medikamentöse Behandlung zu initiieren.

Blasenverweilkatheter

- Ist bei der Aufnahme ein Blasenverweilkatheter vorhanden, ermittelt die Pflegefachkraft, wann und warum er gelegt wurde, und bespricht gemeinsam mit dem behandelnden Arzt die Notwendigkeit bzw. das weitere Vorgehen.
- Ist bei einer Entlassung oder Verlegung in eine andere Einrichtung ein Blasenverweilkatheter vorhanden, ist im Rahmen des Entlassungsmanagements insbesondere der Zeitpunkt und Grund der Anlage des Katheters weiterzugeben.

Miktionsprotokoll oder Miktionsstagebuch

- Objektiviert die Trink- und Ausscheidungssituation
- Stellt eine Grundlage für die Beratung der Betroffenen und der Planung von Interventionen
 - Informationen zu Art, Menge und Uhrzeit der Flüssigkeitsaufnahme,
 - das Wissen um Zeiten, Miktionsmengen und Intervalle der Toilettennutzung oder aufgetretener Inkontinenzereignisse.
- Der Zeitraum, über den das Protokoll geführt werden sollte, hängt vom Krankheitsbild und von individuellen Gegebenheiten ab.
- Empfohlen wird ein Zeitraum von 3 bis max. 5 Tagen, jeweils über 24 Stunden.
- Grundsätzlich sind Aufwand und Nutzen für das Führen eines solchen Protokolls fachlich abzuwägen.

Restharnbestimmung (idealerweise sonographisch) wird mit dem behandelnden Arzt besprochen und durchgeführt

- bei rezidivierenden Harnwegsinfekten,
- dem Gefühl einer nicht vollständig entleerten Blase,
- Toilettengängen in kurzen Abständen
- bei dem Nachträufeln von Urin nach erfolgter Miktion
- bei Risikofaktoren für Restharn (z. B. bestimmte Erkrankungen, Medikation)

Die Messung wird unmittelbar (max. 10 Min.) nach der Miktion durchgeführt.

Vorlagengewichtstest

- dient der quantitativen Erfassung von Inkontinenzereignissen und so auch der späteren Evaluation der Kontinenzförderung.
- Dabei wird erfasst, wie viel Flüssigkeit in einer festgelegten Zeit unwillkürlich ausgeschieden wird.
- Im Rahmen des Entlassungsmanagements kann der Test wichtige Hinweise liefern, um die adäquate Vorlagenversorgung im häuslichen Umfeld sicherzustellen.
- Spezifische Aspekte für eine vertiefte Einschätzung der Stuhlinkontinenzüberprüfung der Schließfähigkeit des Anus
 - (durch geschulte Pflegefachkräfte oder ärztliches Personal)
- Hinweise auf Infekte
 - bei auffälligem Stuhl sollte eine Stuhlprobe für die Bestimmung pathogener Keime initiiert werden.
- Informationen zu Vor- und Begleiterkrankungen, ggf. proktologisch-/gastroenterologischen Vorbefunden
- Informationen zu bestehenden funktionellen Einschränkungen

1.2.2.2 Spezifische Aspekte für eine vertiefte Einschätzung der Stuhlinkontinenz

- Überprüfung der Schließfähigkeit des Anus (durch geschulte Pflegefachkräfte oder ärztliches Personal)
- Hinweise auf Infekte
 - bei auffälligem Stuhl sollte eine Stuhlprobe für die Bestimmung pathogener Keime initiiert werden.
- Informationen zu Vor- und Begleiterkrankungen, ggf. proktologisch-/gastroenterologischen Vorbefunden
- Informationen zu bestehenden funktionellen Einschränkungen
- Stuhlbeobachtung (Stuhltagebuch)
- strukturierte und systematische Erfassung des Trink- und Ernährungsverhalten
- Erfassung der Defäkation mittels Stuhltagebuch
 - Einschätzungsinstrumente zur Stuhlbeschaffenheit z. B. der Einsatz der Bristol Stool Scale

- Weitere Angaben zu den Stuhlgewohnheiten (Dauer und Sitzposition), der Häufigkeit, der Menge und der Konsistenz,
- Je nach individueller Situation der betroffenen Person ist eine Erhebung über mehrere Tage (Richtwert 7 bis 14 Tage) sinnvoll
- Stuhl drainagesystem
 - die Indikation und Verweildauer werden überprüft und dokumentiert
 - Die Indikation bzw. Notwendigkeit und Lage des Drainagesystems sind täglich zu prüfen.
 - Die Liegedauer richtet sich nach Herstellerangaben und muss entsprechend eingehalten werden

1.2.3 Psychosoziale Aspekte der vertieften Einschätzung bei Harn- und Stuhlinkontinenz

- Einschränkungen, Leidensdruck und das Belastungserleben können mittels Skalen erfasst werden
- Zwei Instrumente werden empfohlen
 - **King's Health Questionnaire (KHQ)** bei der Harninkontinenz
 - **Cleveland-Clinic-Score (CCS)** bei Stuhlinkontinenz
- die Strategien der Betroffenen im Umgang mit der Inkontinenz, dazu gehören Verhaltens- und Bewältigungsfaktoren
 - die Hygienepräferenz
 - Isolation/Rückzug im Hinblick auf Aufenthalt in der Nähe einer Toilette
 - Erfahrungen mit und Ängste vor Inkontinenzereignissen in der Öffentlichkeit
 - Schamerleben, Umgang mit Scham
 - Auswirkungen auf Berufsalltag und Freizeitgestaltung und entsprechende Bewältigungsstrategien
 - finanzielle Belastungen
 - das Thema Sexualität/Sexualverhalten ist stets mit zu bedenken
 - einerseits als Risikofaktor im Rahmen genitaler/analer Verletzungen und erlebter sexueller Gewalt auf
 - andererseits im Kontext von Scham und Rückzug bei bestehender Inkontinenz

Pflegefachkräfte sollten sich dessen bewusst sein und das Gesprächsangebot individuell am Gegenüber und der Gesprächssituation ausrichten. Im Zusammenhang mit der Erfassung und Beschreibung psychosozialer Belastungen der Betroffenen können Pflegeklassifikationssysteme hilfreich sein

- Z. B. die **NANDA I** und den darin enthaltenen Diagnosen
 - Gefahr der Machtlosigkeit
 - Machtlosigkeit
 - Hoffnungslosigkeit
 - Chronischer Kummer oder
 - Geringes Selbstwertgefühl